

33-L'Appareil Génital Féminin

Donc, Wolf, c'est le tout premier. C'est ce petit canal qui apparaît, qu'on appelle le ductus mesonephrotique. Ce canal de Wolf, il descend. Chez nous, il va être repris entre les testicules, jusqu'à former le canal éjaculateur, tandis que le canal de Muller, il va rester comme vestige en bas, le cœur de la prostate. Maintenant, chez la femme, c'est l'inverse. Le canal de Wolf se différencie en organes de Gardner chez la femme, c'est-à-dire que c'est ce qui reste, tandis que le canal de Muller, par fusion, devient l'utérus et les trompes chez la femme. Même image qu'on avait vue tout à l'heure, sauf qu'on a toujours le ligament inguinal, ou le ligament suspenseur testiculaire, ou le ligament gubernaculum. On va regarder le canal ici, maintenant on prend le vert. Ça donnait ce qu'on appelle le canal épididyme, le canal déférent, et le canal éjaculateur. Ça vient depuis cette relation uro-génitale, donc ici. Après, chez la femme, ceci ne se développe pas. Les messieurs rénales, elles sont plus grandes, donc elles créent le canal de Muller chez l'homme, mais elles ne le créent pas. Le canal de Muller se réunit vers la ligne centrale, ici comme ceci, et vont former en fait ce qu'on appelle l'utérus. Et les petits organes ici, les organes de Gardner, sont le vestige de notre canal, et le canal éjaculateur, c'est vraiment à chaque fois orienté vers la base ici, et plus on s'écarte sur le côté, plus ça va former l'utérus. Moins on s'écarte, plus le vestige sera le tricule prostatique. Chez l'homme et chez la femme, c'est du péritoine pariétal postérieur, qui est concentré, ce ligament large, ou on appelle ça, tu vois, ces petits ligaments ovariens, ou les ligaments ronds, etc. C'est vraiment le même tissu, mais avec des concentrations différentes. C'est le même péritoine pariétal postérieur, et là on va former l'utérus ici, tu vois. Et chez l'homme, il n'y a pas ce mouvement-là, il reste juste ceci. Mais c'est une concentration de péritoine. Tu as le rein, et au-dessus, la surrénale. Tu as une capsule ici, et c'est séparé. C'est séparé ici, ce qui fait que quand tu as une ptose rénale, tu n'as pas de ptose surrénalienne. Elles

sont séparées. C'est un fascia qu'on appelle la capsule de glissons. Le rein, il a besoin d'un espace graisseux. Chez les femmes qui sont très minces, il y a une ptose du rein, elles ont peu de règles et peu de fertilité. Donc remonter un rein, c'est redynamiser le rein pour sa fertilité. Au départ, elles sont énormes. dans un petit embryon, comme le foie, c'est énorme. C'est comme au départ, ton cerveau, il est comme ça, par rapport au tronc, tu vois. Mais ça, c'est des choses qui changent, tu vois, après. Ce qu'on retient, c'est que le foie a une information importante sur mes surrénales. C'est la première fois où on voit une différenciation dans la structure entre l'homme et la femme. Et c'est en fait lié à ce développement de mes glandes qui sont plus importants et qui créent le tubercule de Muller. Cinquième semaine, ça commence. Tu as ce système sous le côté qui va se développer ici. Redonner toute la puissance du rein. Le cerveau va influencer la mise en place du cœur, qui va mettre en place cette diaphragmatisation, ce foie, les surrénales, les gonades, la crête, le canal de Muller, qui se développe beaucoup plus fort à créer un canal pur chez la femme, Qui se rejoint pour former l'utérus. Chez l'homme, ça se développe un peu moins. Mais ce qui reste en bas du canal du Muller, c'est le cœur de la prostate. Là-dessus, il y a la descente testiculaire par la vitesse de croissance différenciée au niveau du gubernaculum qui se ralentit et qui va tirer tout le système. C'est ça qui m'intéresse pour vous montrer. C'est vraiment cette continuité faciale entre l'utérus, entre toute la partie, on va dire, du fascia, de la peau, du petit bassin. Tu vois, c'est vraiment... Là, on voit bien. On voit bien l'utérus, on voit bien les ligaments, les ovaires, pardon, la cavité péritoniale, finalement. Et là, on va prendre des pinces et on va soulever l'utérus, tu vois. Et on va voir qu'en regardant, quand je tire... Alors, imaginez, par exemple, un fibro, moi, un kyste, et regardez comme tout va changer. N'oubliez pas la continuité, finalement, avec les ligaments. Regardez, je soulève. Et regardez comme... Après, on va

tirer plus fort. Regardez, tu vois comment ça joue partout. Les ligaments ronds. Comment tout ça, c'est du péritoine, en fait. C'est un tissu super intelligent. Et regardez, regardez, regardez ce qui se passe. Regardez l'influence d'un fibrome, par exemple. Comment ça modifie tout le système derrière, ici. Simplement, par une simple traction, comment ça peut influencer tout mon système. Imaginez un fibrome. Il y a des fibromes gros. Eh bien, toute la cascade que ça peut avoir.